

Análise Estratégica — Satélite **Amil**

Empresarial

Mercado de plano de saúde empresarial/PME · concorrentes & tempo de mercado · gaps · raspagem do nosso site · comparação lado a lado com o site oficial · veredicto Go/No-Go

Analista: Atlas (AIOs Decoder) + Squad AIOs — 8 agentes, 153 buscas web

Cliente: BenefícioRH — Agnaldo Silva · Corretor autorizado SUSEP 201054484

Projeto: planoamilempresas.com.br · Next.js 16 + React 19 + Sanity + Cloudflare/Vercel · Operadora-alvo: Amil (ANS 326305)

Data: 30 de maio de 2026 · **Solicitante:** Agnaldo Silva

🎯 **TL;DR brutalmente honesto:** O satélite ataca o ponto **mais quente** do mercado no momento certo: o coletivo empresarial já é **84% das vidas** (53,18 mi total), o individual está em **extinção** (-5,5%/ano) empurrando todos para o CNPJ, e o **boom de MEI** (13,1 mi ativos, +3,8 mi em 2025) cria demanda transacional explosiva. A Amil está em momento **ótimo** (turnaround: lucro R\$ 619 mi em 2024, +874 mil vidas em 2025 — a que mais cresceu no Brasil, líder no RJ e vice em SP). O abismo é digital: o site oficial **não publica preço PME, não tem páginas por cidade, não indexa a rede credenciada, não tem simulador nem comparativos** — deixando o maior volume transacional órfão. A janela é a cauda longa transacional+geo+rede (KD 30-45) e, sobretudo, a camada **HOSPITAL×CIDADE** ("o hospital X aceita Amil?") — oceano azul que nenhum dos 10+ satélites EMD concorrentes faz, e que só nós temos dataset para gerar (9.325 prestadores). **Veredicto: GO CONDICIONAL.**

84%

das vidas são coletivas (ANS mar/26)

13,1 mi

MEIs ativos (+3,8 mi em 2025)

8/10

saturação SERP no head

~11 mil

URLs-alvo do nosso satélite



Bloco 1 — Mercado empresarial/PME: o vetor mais quente do setor

Indicador	Valor	Significado para o satélite
Beneficiários (assistência médica, BR)	53,18 milhões	Dez/2025, recorde ANS; crescimento puxado ~100% pelo coletivo
Participação dos planos COLETIVOS	84%	Mar/2026; era 71,9% (só empresarial) em dez/2024 — domínio absoluto
Participação do INDIVIDUAL	16,4% (8,6 mi)	Em queda -5,5%/ano; operadoras quase não vendem mais novo
MEIs ativos / novos em 2025	13,1 mi / +3,8 mi	Recorde (+22,1%); demanda "plano MEI/PJ/2 vidas" explode
Contratos coletivos de até 5 vidas	15,3%	Era 4,7% em 2014 — micro/PME é o segmento que mais cresce
Economia PJ vs PF (cobertura equivalente)	~30% (até 30-50%)	MEI ~40% mais barato; argumento de conversão central
Ticket médio empresarial / entrada Amil MEI	R\$ 180-600 · R\$ 127	Micro 2-10 vidas R\$ 150-350/pessoa
Mínimo de vidas (PME/MEI)	2 vidas	Qualquer CNPJ ativo (MEI/ME/EPP/LTDA), 6+ meses
Churn do setor (12 meses)	27,9%	Rotatividade alta = busca constante por cotação/portabilidade (leads quentes)



A tese em uma frase: o individual morre, todo mundo é empurrado para o CNPJ, e o MEI explode — exatamente o tráfego que planoamilempresas.com.br existe para capturar. Vento estrutural + conjuntural ao mesmo tempo.



Bloco 2 — Regulatório: pool de risco, reajuste e o "calcanhar" da Amil

Tema	O que diz	Uso editorial
Reajuste coletivo (sem teto ANS)	Calculado por sinistralidade. Médio 11,15% (2025) · ~9,9% (2026). Individual tem teto: 5,11% (2026)	Conteúdo "reduzir reajuste / cotação anual"
Pool de risco — RN 309/2012 (<30 vidas)	Obriga reajuste ÚNICO para todos os contratos <30 vidas; protege a micro de reajuste explosivo por sinistro isolado	Argumento de segurança PME quase não explorado em SEO
Reajuste <30 vidas vs 30+ vidas (2026)	13,48% vs 8,71% — pequenas pagam ~5 p.p. a mais	Gancho "vale a pena migrar/portar"
Reajuste coletivo da AMIL 2025	15,75% — o MAIOR entre as 10 maiores operadoras (Porto 15,08% · Bradesco 12,62% · SulAmérica 12,45%)	⚠ Objeção real — tratar com honestidade (portabilidade/pool), não esconder
Carência empresarial	30+ vidas geralmente isenta; Amil reduz a partir de 10 vidas vindas de congênere	Urgência/benefício para CTAs
Portabilidade RN 438/2018	Troca sem nova carência (requisitos) — capta insatisfeito de concorrente	Cluster anti-reajuste de alta conversão



O ponto cego da Amil: aplicou o **maior reajuste coletivo de 2025 (15,75%)**. O usuário pesquisa isso antes de fechar. O conteúdo deve **antecipar a objeção** (portabilidade, pool de risco RN 309, cotação anual) e transformá-la em serviço — nunca prometer reajuste baixo.



Bloco 3 — Amil 2026: operadora em turnaround (momento favorável)

Indicador	Valor	Significado
Fundação / tempo de mercado	1978 (~47 anos)	Edson Bueno, RJ; pioneira da verticalização no Brasil
Mudança de controle	Dez/2023 · R\$ 11 bi	UnitedHealth saiu do Brasil → José Seripieri Filho (fundador da Qualicorp). Não "Fiord Capital"
Resultado 2024 (turnaround)	Lucro R\$ 619,8 mi	Reverteu prejuízo de R\$ 4,1 bi (2023); receita R\$ 31 bi (+21%); EBITDA +R\$ 858 mi
Sinistralidade (MLR) 2024	84,8%	Queda de 12 p.p. no 1º ano da nova gestão
Crescimento de vidas 2025	+874 mil (a que mais cresceu)	~6,1 mi clientes (+17%); líder no RJ, vice-líder em SP , +13% vs mercado ~2%
IDSS / ANS (ano-base 2023)	~0,78 (8,2/10)	Abaixo de Bradesco ~0,94 e SulAmérica ~0,92; média setor 0,7805
Reclame Aqui	7,7/10 (BOA)	7.722 reclamações, 76,9% resolvidas — acima da Hapvida
Rede	+1.700 hospitais	+28 mil consultórios, +6 mil labs; ~14 hospitais próprios (metropolitana SP) + Américas (RJ)
Linha empresarial	comercial 200/400/700 · dataset 30-160/S380-S750/ONE	⚠️ nomenclatura comercial (corretora) ≠ dataset oficial — usar SKU real no site (anti-thin); PME Porte I (2-29) e II (30-99)

✓ **Diferença vs análises anteriores:** a Amil *era* um risco (saída da UnitedHealth, judicialização de individuais em 2023). Hoje está **financeiramente sã e em expansão**, focada exatamente em coletivo empresarial em SP/RJ/DF. Apostar no satélite Amil empresarial 12-24 meses é decisão muito mais segura agora.



Bloco 4 — Raspagem do nosso site /planoamilempresas (estado atual)

Inventário extraído do código (C:\Users\benef\planoamilempresas). É o **mais ambicioso satélite do portfólio**:

Dimensão	Escopo	Detalhe
Rede credenciada indexável	~10.500 URLs	9.325 prestadores × 49 redes em 26 UFs (dataset Power BI canônico, 2026-04-26) → matriz rede/[uf]/[municipio]/[prestador]
Sub-redes canonizadas (eixo produto)	5	hospitais-dor · amil-one · amil-facil · classica · amil-medial — já modeladas em código com posicionamento próprio (ADR-006)
Matriz programática	~600 URLs	CNAE/segmento × cidade × porte · empresarial/[segmento], plano-amil-[estado]/[cidade]
Comparativos	12	vs Bradesco, SulAmérica, Hapvida, Unimed, Porto, NotreDame, Omint, Care Plus + internos (400 vs 700, One)
Planos Amil	200/400/500/700/S750/One	planos/[slug] + tabela-de-precos/[slug]
Rede por especialidade/sub-rede	✓	rede-credenciada/[especialidade] e [subRede]
Blog + Autores (E-E-A-T)	✓	blog/[slug] + categoria + autores/[slug] + feed RSS
Ferramentas de conversão	✓	cotacao-online, comparar, portal-empresa/[slug]
Conteúdo de apoio	✓	carências, FAQs, glossário, amil-dental, amil-espaco-saude, perguntas-frequentes

Stack: Next 16 · React 19 · Tailwind 4 · Radix · Sanity v3 · Upstash Redis · Cloudflare/Vercel · GA4 + Clarity + Sentry · Vitest/Playwright/axe · CRM Clint.
Compliance: LGPD + ANS RN 195/2009 + 593/2024 + SUSEP. Titular: BeneficioRH (SUSEP 201054484).

✓

Diagnóstico: o site já tem o **ativo decisivo** (dataset de rede de 9.325 prestadores) que vira moat impossível de replicar rápido, além de E-E-A-T (autores), ferramentas (cotação/comparar) e compliance. A base é a mais forte dos satélites. O trabalho é **executar o Epic 7 (rede indexável) e o simulador**, não reinventar.

Bloco 5 — Comparação LADO A LADO: nós × oficial × concorrentes

Critério	planoamilempresas (nosso satélite)	amil.com.br/empresas (oficial)	Satélites EMD (planodesaudeamil...)	Agregadores (quero/joov)
Tabela de preço PME por cidade/idade/porte	planejado	não publica	raso	forte
Rede credenciada INDEXÁVEL por cidade/hospital	~10.500 pgs	busca JS	não	não
Simulador/calculadora de cotação	cotacao-online	só formulário	não	genérico
Comparativos (interno e vs concorrente)	12	zero	zero	lista
Páginas por profissão/CNAE × cidade × porte	~600	genérico	não	genérico
Autor humano / E-E-A-T (corretora SUSEP)	autores + SUSEP	institucional	anônimo	anônimo
Autoridade de domínio / marca	novo	alta	média	alta
Conteúdo de objeção (reajuste/pool/portabilidade)	planejado	não	não	genérico

Leitura: vencemos em **profundidade de rede, ferramentas, comparativos e E-E-A-T**; perdemos em **autoridade de domínio** (somos novos). O site oficial é forte em marca mas **digitalmente cego** no transacional. Os satélites EMD têm head-start de indexação mas são rasos — nosso dataset de rede (10.500 pgs) + ferramentas os supera.

Bloco 6 — Mapa de concorrentes & tempo de mercado

Operadora	Fundação	Vidas	Posição no B2B
Hapvida / NotreDame (GNDI)	1979/1968	~9-16 mi	Líder por vidas; verticalizado, preço PME imbatível; qualidade percebida menor
Unimed (sistema)	1967 (~58a)	~18 mi	Maior cobertura (84% do território); fragmentado por singular
Bradesco Saúde	1984 (~42a)	~3,5-4 mi	Líder segurador B2B (~96% coletivo); premium, não verticalizado; só PJ
SulAmérica	1895 (130a)	~2,5-3 mi	Premium tradicional; sinergia Rede D'Or pós-2022; linha Prestige
Porto Seguro Saúde	1945 (grupo)	~500-600 mil	Forte em PME SP; cross-sell ecossistema Porto; cobertura limitada
Omint	1980 (~45a)	~100-130 mil	Boutique premium executivo (Einstein/Sírio); nicho
Care Plus (Bupa)	1992 (~33a)	~150-200 mil	Premium corporativo/multinacionais; cobertura internacional
Amil (nossa operadora-alvo)	1978 (~47a)	~6,1 mi	Verticalizada; a que mais cresceu em 2025 ; líder RJ, vice SP; turnaround

 **Insight de posicionamento:** a Amil é a **única grande verticalizada em forte expansão** com foco declarado em coletivo empresarial em SP/RJ/DF — exatamente as praças onde a rede própria e o crescimento se concentram. É o terreno do nosso satélite geo.

● Bloco 7 — SERP: 8/10 no head, 4-5/10 na cauda longa-alvo

Keyword	Volume/mês	Dificuldade	Estratégia
plano de saúde empresarial	40.500-49.500	KD 55-65	evitar head
plano de saúde CNPJ	14.800-22.200	KD 50-60	evitar head
plano de saúde para empresa	12.100-18.100	KD 50-60	evitar head
plano de saúde PME	8.100-12.100	KD 45-55	meio de funil
Amil empresarial	6.600-9.900	KD 40-50	marca — disputável
plano de saúde MEI	5.400-8.100	KD 40-50	JANELA (boom MEI)
Amil empresarial preço / tabela 2026	2.400-4.400	KD 30-45	JANELA — oficial ausente
Amil PME	1.900-3.600	KD 35-45	JANELA
Amil PME / rede Amil [cidade]	long-tail	KD 25-40	JANELA geo — espaço quase vazio

Linhas verdes = janelas reais. Quem domina o top 10: agregadores (queroplanodesaude, joov, iquota, Qualicorp) no head; **amil.com.br #1 só na própria marca**; satélites EMD exact-match (planodesaudeamil.net.br, amilplanodesaude.net) dominam "tabela/preço Amil"; o oficial NÃO ranqueia para preço/tabela/rede.

● Bloco 8 — Os 3 gaps mais lucrativos

Gap nº1 — HOSPITAL×PRODUTO×CIDADE (oceano azul absoluto). Os 10+ satélites EMD fazem páginas por produto e por cidade, mas **quase nenhum por hospital individual** ("Hospital São Camilo aceita Amil?", "rede Amil One em [cidade]"). O oficial usa busca JS não-rankeável. Com o dataset de **9.325 prestadores (cada um com seu array de redes) já extraído**, essa camada é gerável automaticamente — intenção transacional-decisão, concorrência editorial quase nula. É o moat que diferencia de todo EMD thin.

Gap nº2 — Tabela de preço + simulador Amil empresarial. O maior volume transacional ("amil empresarial preço", "tabela amil pme 2026", "amil 400 valor") é órfão — o oficial manda ao corretor. Tabela por produto + **calculadora de cotação** (vidas + faixas + cidade → estimativa + economia PJ vs PF) é o gap de conversão central.

Gap nº3 — Matriz profissão/CNAE × cidade × porte + objeção. Páginas por segmento de empresa, cidade e porte (2-29/30-99/100+ vidas) + comparativos (400 vs 700 vs One; Amil vs Bradesco/SulAmérica/Hapvida) + conteúdo de objeção (reduzir reajuste, portabilidade, pool de risco RN 309) — fundo e meio de funil ignorados pelo oficial.

Bloco 9 — Por que a estrutura programmatic própria vence

Vantagem	Evidência / número
Data moat irreplicável	Dataset de rede Amil (9.325 prestadores, 26 UFs) → ~10.500 páginas que nenhum EMD/agregador tem; cobertura long-tail impossível de igualar manual
E-E-A-T de corretora autorizada	SUSEP 201054484 + CNPJ + autoria real + disclaimers = Trust superior em nicho YMYL; 88% das queries de saúde têm AI Overview
Lead próprio exclusivo	vs lead de marketplace revendido a vários corretores; CAC decrescente (conteúdo é ativo), dado primário alimenta CRM (Clint)
Especialização = conversão	Foco 100% Amil empresarial dá coerência e relevância vs agregador generalista; funil marca + transacional
Controle e velocidade	100% do conteúdo, schema, Core Web Vitals, A/B — responde a tendências (boom MEI, reajuste) em dias, não trimestres
Programmatic scale	Matriz plano×cidade×porte×profissão + rede×cidade (modelo Zapier/NerdWallet) — long-tail que oficial e agregador não alcançam

Bloco 10 — Reputação comparada (Reclame Aqui)

Operadora	Nota RA	Leitura
Bradesco Saúde	~8,1	Topo do pelotão
SulAmérica	~8,0	Boa
Porto Seguro Saúde	~8,0	Boa reputação de atendimento
Amil	7,7	BOA · 7.722 reclamações · 76,9% resolvidas · 72,2% voltariam
Hapvida / NotreDame	~7,0-7,5	Volume altíssimo de reclamações

✅ **Boa notícia vs MedSênior:** diferente do nicho sênior (onde a operadora tinha RA 5,78), a **Amil tem reputação BOA (7,7) e acima da Hapvida**. Isso permite comunicação de qualidade — a única objeção real a gerenciar é o **reajuste** (Bloco 2).

Veredicto & Plano de Ação



VEREDICTO: GO CONDICIONAL. Mercado (coletivo 84%, boom MEI, individual em extinção), operadora (Amil em turnaround, líder de crescimento, forte em SP/RJ/DF) e gap digital (oficial sem preço/geo/rede/simulador) convergem para uma janela rara. O projeto já está ~80% pronto (Caminho C) com o ativo decisivo (dataset de 9.325 prestadores) e 5 sub-redes modeladas. **2 condições inegociáveis** para virar GO pleno ↓

#	Condição inegociável
1	Blindagem de marca + desbloquear Story 7.7 (ADR-006 "URL-as-Trademark"): disclaimer "não somos a Amil", sem logo, titular BenefícioRH/SUSEP, e-mail próprio, slug nunca "amil" sozinho, marca defensiva INPI — antes de escalar tráfego
2	Atacar SÓ meio/fundo de funil + geo + HOSPITAL×CIDADE via data moat — nunca competir no head (KD 55-65) dominado por agregadores; a ideia e o domínio já não são diferencial, só o dataset é

Diretriz de conteúdo permanente: tratar a objeção de reajuste com honestidade (Amil teve o maior coletivo de 2025: 15,75%) — portabilidade/pool RN 309/cotação anual, nunca prometer reajuste baixo.

Roadmap priorizado P0 → P2

Prio	Ação	Impacto
P0	Lançar cluster de rede credenciada indexável (Epic 7) : 9.325 prestadores → páginas SSG/ISR. Priorizar SP capital/ABC, RJ, BH, Brasília. Schema MedicalBusiness/Hospital	Maior moat + tráfego B2B de altíssima intenção que o oficial perde (~10.500 pgs)
P0	Simulador/calculadora de cotação PJ (vidas + faixas + cidade + porte → estimativa + economia vs PF) com captura para o CRM Clint + tabela de preços por produto c/ disclaimers ANS	Preenche o gap de conversão central; lead qualificado exclusivo
P0	Blindagem jurídica de marca: disclaimer corretora, sem logo oficial, titular BenefícioRH/SUSEP, e-mail próprio, termos, marca nominativa defensiva INPI	Mitiga o maior risco (SACI-Adm/uso indevido); compliance vira Trust
P1	Cluster de comparativos de fundo de funil (400 vs 700 vs One; Amil vs Bradesco/SulAmérica/Hapvida) factual e fonte-referenciado	Captura intent comparativo ignorado pelo oficial; autoridade tópica
P1	Matriz profissão/CNAE × cidade × porte (~600 URLs) com conteúdo único por cruzamento	Domina long-tail transacional+geo de KD baixo
P1	Cluster de objeção/retenção : reduzir reajuste, portabilidade Amil, pool de risco RN 309, reajuste Amil 2026	Captura insatisfeitos (churn 27,9%) e converte via cotação/portabilidade
P2	Otimizar para AI Overviews : schema completo, respostas 40-60 palavras, autoria SUSEP	Citação na IA (88% das queries de saúde têm AIO; 60-69% zero-click)
P2	Conteúdo de timing: "boom MEI", "plano PJ 2 vidas", calculadora economia PJ vs PF; atualizar reajustes em maio	Surfa a tendência estrutural (MEI + extinção do individual)
P2	Preparar arquitetura multi-operadora (caminho C)	Diversifica risco de dependência da Amil; reaproveita o motor programático

Riscos a monitorar

Risco	Nível	Mitigação
Marca de terceiro "Amil" no domínio	Alto	Disclaimers, sem logo, titular corretora, marca defensiva INPI
SERP saturada no head (KD 55-65)	Méd-alto	Foco disciplinado em long-tail+geo+rede
Objecção de reajuste Amil (15,75% em 2025)	Médio	Conteúdo honesto de portabilidade/pool/cotação
Dependência de operadora única	Médio	Arquitetura multi-operadora futura (caminho C)
Compliance ANS de publicidade (RN 195/2009)	Médio	Registro ANS do produto, "sujeito a condições", fonte-referência
Manutenção do dataset de rede (YMYL)	Méd-baixo	Pipeline de atualização periódica + revalidação ISR



Anexos & Fontes

Arquivos gerados (em C:\Users\benef\analises-seo\):

- relatorio-amil-empresarial.pdf / .html — este relatório
- amil-analise-completa-2026-05-30.md — markdown-fonte
- amil-concorrentes.csv — 8 operadoras × tempo de mercado / vidas / posição B2B
- amil-serp-keywords.csv — volume × intent × dificuldade
- amil-comparacao-lado-a-lado.csv — nós × oficial × EMD × agregadores
- amil-reclame-aqui.csv — reputação comparada

Fontes-chave: ANS (53,18 mi beneficiários dez/2025; coletivo 84%; reajustes coletivos; RN 309/2012; RN 195/2009; RN 438/2018), Sebrae/Receita (13,1 mi MEIs; +3,8 mi em 2025), InfoMoney/CNN/Exame (venda Amil R\$ 11 bi a José Seripieri Filho; turnaround lucro R\$ 619,8 mi 2024), Reclame Aqui (Amil 7,7; Bradesco ~8,1; SulAmérica ~8,0; Hapvida ~7,0-7,5), CQCS (reajuste Amil 15,75% maior top 10), BrightEdge/SE Ranking (AI Overview 88% saúde), memórias do projeto (dataset rede 9.325 prestadores). Lista completa de 153 buscas no markdown-fonte.